Recommandation SPILF 2017 Encéphalites infectieuses aiguës de l'adulte

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF
7 avril 2017

Sociétés savantes partenaires

- Association pédagogique nationale pour l'enseignement de la thérapeutique (APNET)
- Société Nationale Française de Médecine interne (SNFMI)
- Fédération française de Neurologie (FFN)
- Société de réanimation de langue française (SRLF)
- Société française d'anesthésie réanimation (SFAR)
- Société Française de microbiologie (SFM)
- Société française de neuroradiologie (SFNR)
- Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER)

Synthèse réalisée par la SPILF

Evoquer une encéphalite infectieuse aiguë et la confirmer

- **La clinique**
  - ✓ Tout symptôme ou signe de dysfonctionnement du SNC associé à la fièvre
  - ✓ La fièvre doit être recherchée dans les jours précédents par l'interrogatoire du patient ou des proches.

Evoquer une encéphalite infectieuse aiguë et la confirmer

- **La biologie sanguine**
  - ✓ Deux paires d'hémocultures avant toute antibiothérapie
  - ✓ Numération avec formule sanguine avec plaquettes, ionogramme sanguin, glycémie (concomitante de la PL), CRP, ASAT, ALAT, bilirubine, phosphatases alcalines, bilan d'hémostase et CPK
  - ✓ Sérologie VIH indispensable
    En cas de suspicion de primo-infection VIH, PCR ARN VIH (charge virale)

Evoquer une encéphalite infectieuse aiguë et la confirmer

- **La biologie du LCS (1)**

✓ LCS au moins 120 gouttes (environ 50 microL/goutte)

- 20 gouttes pour biochimie
- 80 à 100 gouttes pour cytologie, microbiologie et virologie
- Conserver une partie du LCS (si possible - 80°C) pour compléments d'investigations (dont le diagnostic de tuberculose)

✓ En urgence : cytologie, protéinorachie, glycorachie, lactates et microbiologie.

✓ Glycorachie impérativement associée à une glycémie concomitante, veineuse ou à défaut capillaire par dextro.

Evoquer une encéphalite infectieuse aiguë et la confirmer

- **La biologie du LCS (2)**
  - ✓ Examen bactériologique standard
  - ✓ PCR HSV, VZV et entérovirus impératives
  - ✓ Recherche de BK si négativité des PCR précédentes ou très forte suspicion clinique ou épidémiologique

Evoquer une encéphalite infectieuse aiguë et la confirmer

- **Ponction lombaire contre-indiquée avant l'imagerie (à faire en urgence) si :**
  - ✓ Troubles de la vigilance
  - ✓ Signes de localisation déficitaires
  - ✓ Crises épileptiques focales ou généralisées
- **Si ponction lombaire impossible, appliquer les recommandations de thérapeutique initiale des méningites bactériennes ET des encéphalites infectieuses**

Evoquer une encéphalite infectieuse aiguë et la confirmer

- **L'imagerie**

✓ IRM cérébrale en urgence en première intention
  - o avec séquences FLAIR
  - o diffusion, T2*, T1 sans et avec gadolinium
  - o séquences vasculaires veineuses et artérielles

✓ Seulement si IRM impossible, tomodensitométrie cérébrale (TDM) sans et avec injection

Conduite initiale (premières 48 h)

- **Hospitalisation**

✓ Dans une unité ayant l'expérience de ces pathologies, et si possible avec une unité de surveillance continue (USC).

✓ En réanimation/soins intensifs si :

- Score de Glasgow (GCS) ≤ 13 **ou**
- Plus d'une crise convulsive, ou état de mal **ou**
- Détresse respiratoire ou une autre défaillance d'organe **ou**
- Troubles du comportement incompatibles avec le secteur conventionnel.

Conduite initiale (premières 48 h)

- **Traitements anti-infectieux (1)**

✓ A débuter en urgence

✓ Absence d'orientation étiologique (clinique ou biologique),
  - Acyclovir : 10 mg/kg IV toutes les 8 heures **et**
  - Amoxicilline : 200 mg/kg/jour en au moins 4 perfusions, ou en administration continue
  - Réévaluation systématique à 48h.

✓ Si vésicules cutanées ou signes de vasculopathie à l'imagerie
  - Acyclovir : 15 mg/kg IV toutes les 8 heures.

Conduite initiale (premières 48 h)

- **Traitements anti-infectieux (2)**

✓ Si LCS trouble : appliquer les recommandations sur la prise en charge des méningites bactériennes communautaires

✓ Si examen microscopique du LCS positif : débuter un traitement étiologique.

Conduite initiale (premières 48 h)

- **Traitements anti-infectieux (3)**

✓ Dans les premières 48 heures :

- Contact avec le microbiologiste
- Résultats PCR HSV, VZV et entérovirus doivent être connus
- Traitement anti tuberculeux (en plus du traitement par acyclovir + amoxicilline) seulement si :
  - Présence d'éléments fortement évocateurs : terrain, anamnèse, caractéristiques du LCS, localisations extra neurologiques, imagerie **ou**
  - Présence de BAAR ou PCR temps réel positive

Conduite initiale (premières 48 h)

- **Traitements anti-infectieux systématiquement réévalués dans les 48 heures avec les résultats disponibles**

✓ Si PCR HSV positive : arrêt amoxicilline et poursuite acyclovir (10 mg/kg/8 heures)

✓ Si PCR VZV positive : arrêt amoxicilline et augmentation acyclovir (15 mg/kg/8 heures)

✓ Si PCR entérovirus positive, arrêt acyclovir et amoxicilline.

✓ Si culture positive à *Listeria* : arrêt acyclovir, poursuite amoxicilline et ajout de gentamicine (5 mg/kg en une dose unique quotidienne)

Conduite initiale (premières 48 h)

- **Si tout est négatif à 48 heures :**
  - ✓ Poursuite acyclovir jusqu'à réévaluation du diagnostic d'HSV/VZV (seconde PCR sur LCS **au moins 4 jours après le début des signes neurologiques**) **et**
  - ✓ Arrêt amoxicilline, sauf si prise d'antibiotique avant la PL ou contexte évocateur de listériose
- **Pas de corticothérapie** sauf si tuberculose prouvée ou fortement suspectée
- **Pas de traitement anticonvulsivant en prophylaxie primaire** (à discuter si lésions corticales)

CAT si diagnostic déjà fait à 48 h

- **Encéphalites HSV (1)**

✓ Acyclovir IV = traitement de référence
  - **Pas de place pour l'acyclovir per os, ni pour le valacyclovir**

✓ Dose acyclovir : 10 mg/kg (ajustée à la fonction rénale) en 1 heure toutes les 8 heures
  - Concentration finale du soluté de perfusion < 5 mg/ml
  - Limiter les traitements néphrotoxiques associés
  - Réhydratation correcte

✓ Durée de traitement :
  - 14 jours chez l'adulte immunocompétent
  - 21 jours si immunodépression

✓ Si évolution favorable : pas de contrôle de LCS.

CAT si diagnostic déjà fait à 48 h

- **<u>Encéphalites HSV (2)</u>**

✓ En cas d'évolution clinique non favorable à la fin du traitement de 14 jours

- Une ponction lombaire avec PCR HSV et recherche d'auto-anticorps sur le LCS doit être réalisée
- La positivité de la PCR HSV peut conduire à prolonger le traitement par acyclovir à 21 jours.
- La recherche d'une résistance à l'acyclovir et l'exploration des paramètres pharmacocinétiques (dosages d'acyclovir dans le sang et le LCS) sont à discuter collégialement.

CAT si diagnostic déjà fait à 48 h

- **<u>Encéphalites à VZV</u>**

✓ Acyclovir IV = traitement de référence

- **Pas de place pour l'acyclovir per os, ni pour le valacyclovir**

✓ Dose acyclovir : 15 mg/kg (ajustée à la fonction rénale) en 1 heure toutes les 8 heures

- Concentration finale du soluté de perfusion < 5 mg/ml
- Limiter les traitements néphrotoxiques associés
- Réhydratation correcte

✓ Durée de traitement : 14 jours

✓ Foscarnet = seconde intention si échec, intolérance, ou résistance à l'acyclovir

✓ Pas de corticothérapie systématique

CAT si diagnostic déjà fait à 48 h

- **Encéphalite à *Listeria***

✓ Traitement recommandé
  - Amoxicilline à 200 mg/kg/jour en au moins 4 perfusions par 24 h ou en continu, pendant 21 jours
  - Gentamicine 5mg/kg/j en dose unique quotidienne, pendant au maximum 5 jours

✓ Si contre-indication à l'amoxicilline, triméthoprime/sulfaméthoxazole à forte dose : 6 à 9 ampoules de 80mg/400mg par jour, en 3 injections, pendant 21 jours en IV.

CAT si diagnostic déjà fait à 48 h

- **<u>Encéphalite tuberculeuse (1)</u>**

✓ Jusqu'aux résultats de l'antibiogramme
  - Isoniazide (I) (5mg/kg/j)
  - Rifampicine (R) (10 mg/kg/j)
  - Pyrazinamide (P) (30 mg/kg/j sans dépasser 2 g)
  - Ethambutol (E) (20 mg/kg/j)

✓ Arrêt de l'éthambutol si souche sensible à l'isoniazide

✓ Durée initiale de 2 mois

✓ Puis bithérapie par IR pour une durée totale de 12 mois

CAT si diagnostic déjà fait à 48 h

- **<u>Encéphalite tuberculeuse (2)</u>**

✓ Adjonction systématique de dexaméthasone :

- 0,3 à 0,4 mg/kg/jour par voie intraveineuse, en fonction de la gravité initiale
- Décroissance sur 8 semaines dès la fin de la première semaine

✓ La neurochirurgie doit être discutée sans attendre en cas d'hydrocéphalie, de tuberculome/abcès ou de compression médullaire.

CAT si diagnostic déjà fait à 48 h

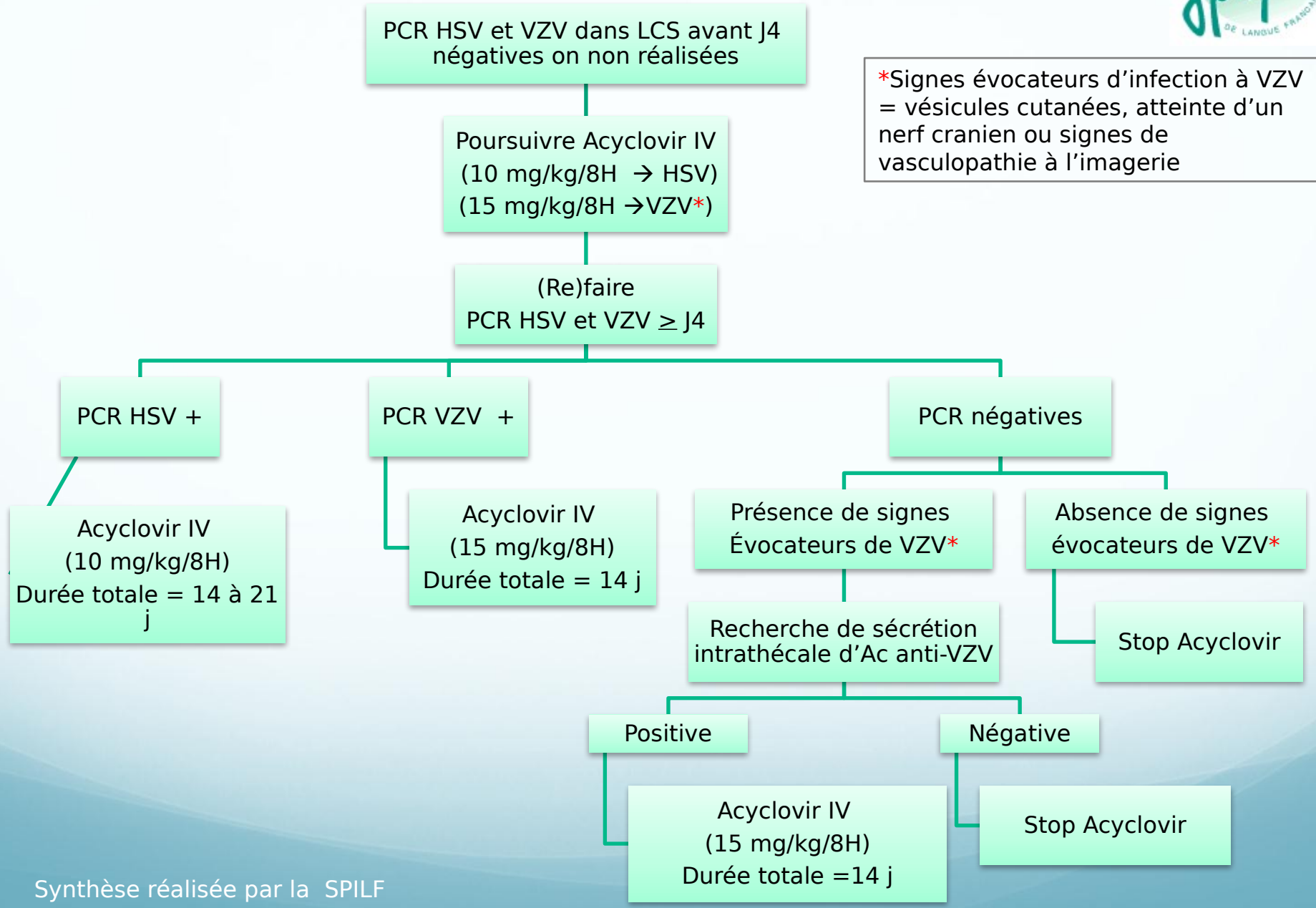
- **<u>Encéphalite tuberculeuse (3)</u>**

✓ La surveillance biologique du traitement est identique à celle recommandée dans le traitement des autres localisations de tuberculose

✓ En cas d'évolution clinique favorable

- Pas de ponction lombaire de contrôle
- Pas d’imagerie de contrôle

Faut-il poursuivre l'acyclovir si PCR HSV et VZV négatives ?



*Signes évocateurs d'infection à VZV = vésicules cutanées, atteinte d'un nerf cranien ou signes de vasculopathie à l'imagerie

Synthèse réalisée par la SPILF

CAT si diagnostic non fait à 48 h

- **Faut-il poursuivre l'amoxicilline ?**

✓ **OUI** : en cas d'éléments cliniques en faveur d'une listériose, même en l'absence de documentation microbiologique

✓ **NON** : en l'absence d'éléments cliniques en faveur de listériose, l'amoxicilline peut être arrêtée si prélèvements microbiologiques négatifs.

CAT si diagnostic non fait à 48 h

- **Faut-il instaurer ou poursuivre une quadrithérapie antituberculeuse d'épreuve après 48h ? (1)**

✓ **OUI** : si le tableau clinique, biologique et l'imagerie sont en faveur d'un diagnostic de tuberculose, même en cas d'examen microscopique et de PCR négatifs

- La PCR-Temps réel doit être réalisée sur des échantillons dont le volume reçu est au minimum de 2 ml (40 gouttes), et qui devront être centrifugés avant d'être testés
- La PCR-Temps réel négative ne permet pas d'éliminer le diagnostic de tuberculose
- Les tests interféron (IGRA) dans le sang et le LCS ne sont pas recommandés

CAT si diagnostic non fait à 48 h

- **Faut-il instaurer un traitement par corticoïdes en cas de diagnostic non fait à 48h ?**

✓ **Non sauf si** :

- Méningo-encéphalite tuberculeuse suspectée ou prouvée,
- Décision après concertation multidisciplinaire.

CAT si diagnostic non fait à 48 h

- **Faut-il instaurer un traitement d'épreuve par doxycycline ?**

✓ A discuter si suspicion d'encéphalite à bactéries intracellulaires et en l'absence d'argument pour une des 4 étiologies les plus fréquentes.

CAT si diagnostic non fait à 48 h

- **Poursuite de l'investigation diagnostique (1)**

✓ Les investigations infectieuses complémentaires doivent être orientées par l'âge, le terrain, les expositions professionnelles ou de loisir, la saison, les voyages, les signes extra-neurologiques et les données biologiques.

CAT si diagnostic non fait à 48 h

- **Poursuite de l'investigation diagnostique (2)**

✓ Une IRM est indispensable pour faire le diagnostic d'ADEM.

✓ Si encéphalite limbique ou de cause indéterminée

  ✓ Recherche d'encéphalite auto-immune par détection d'anticorps onco-neuronaux sériques et du LCS

  ✓ Recherche de maladie systémique.

CAT si diagnostic non fait à 48 h

- **Poursuite de l'investigation diagnostique (3)**

✓ **Biopsie cérébrale**

- Si encéphalite non résolutive d'étiologie indéterminée,
- Après réunion multidisciplinaire.
- Comprenant systématiquement des prélèvements non fixés (microbiologie) et fixés (anatomopathologie).